

CARDIOLOGIE

Hypertension Artérielle

Année 2025-2026

ITEM 224

LÉGENDE

- ★ Déjà tombé aux ECN
- ◆ Notion à haut rendement
- ⚠ Piège classique

Item 224

Plan du cours

Cardiologie · Hypertension Artérielle

I Définition et épidémiologie

Cadre nosologique et poids de santé publique.

A. Définitions et seuils — Seuils et grades.

B. Épidémiologie — Prévalence et FdR.

II Diagnostic et bilan initial

Confirmation et recherche du retentissement.

A. Mesure de la PA — Conditions et MAPA.

B. Bilan de retentissement — Organes cibles.

III Prise en charge thérapeutique

Mesures hygiéno-diététiques et médicaments.

A. Mesures non médicamenteuses — RHD.

B. Traitement médicamenteux — Classes.

I | Définition et épidémiologie

I	A. Définitions et seuils														
★ Définition de l'HTA	• HTA : PAS ≥ 140 mmHg et/ou PAD ≥ 90 mmHg au cabinet • diagnostic confirmé sur deux consultations • automesure : seuil abaissé à ≥ 135/85 mmHg														
◆ Grades de sévérité	<table><tr><th>Grade</th><th>PAS (mmHg)</th><th>PAD (mmHg)</th></tr><tr><td>Grade 1</td><td>140-159</td><td>90-99</td></tr><tr><td>Grade 2</td><td>160-179</td><td>100-109</td></tr><tr><td>Grade 3</td><td>≥ 180</td><td>≥ 110</td></tr></table>			Grade	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)	Grade 1	140-159	90-99	Grade 2	160-179	100-109	Grade 3	≥ 180	≥ 110
Grade	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)													
Grade 1	140-159	90-99													
Grade 2	160-179	100-109													
Grade 3	≥ 180	≥ 110													

PIÈGE

Ne pas confondre l'**HTA blouse blanche** (PA élevée au cabinet uniquement) et l'**HTA masquée** (PA normale au cabinet, élevée en ambulatoire) : le pronostic diffère.

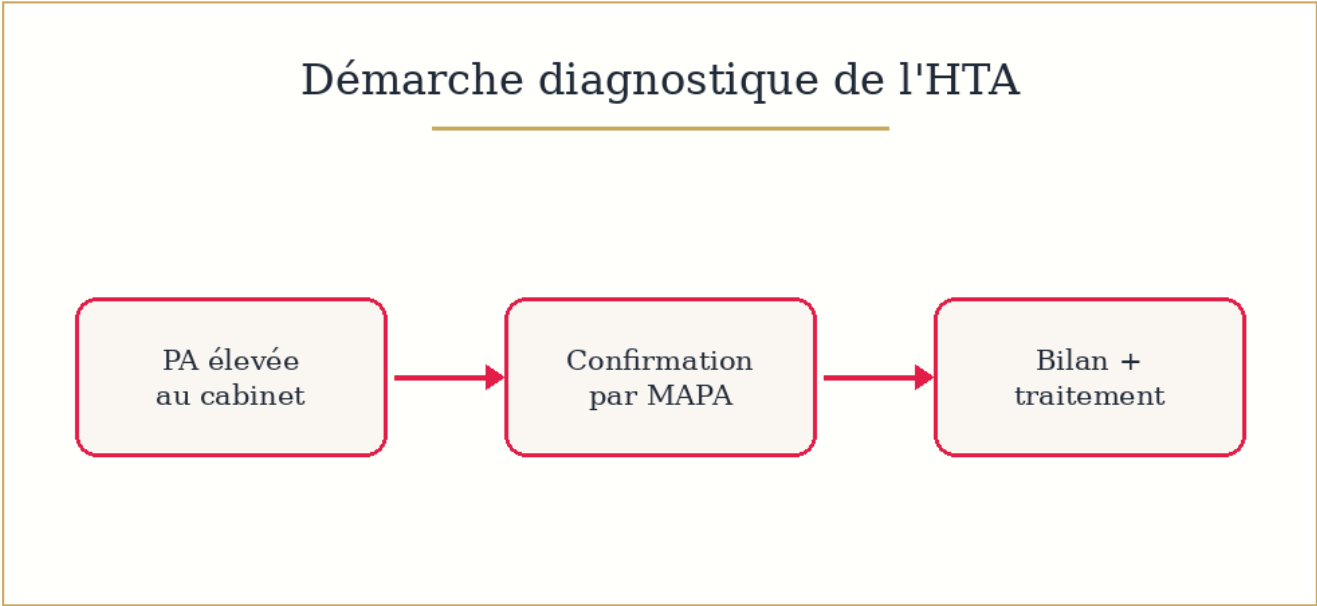


Figure 1 — Étapes de la démarche diagnostique devant une pression artérielle élevée.

I	B. Épidémiologie
Prévalence	• environ 30 % de la population adulte • augmente avec l'âge • premier motif de consultation en médecine générale
◆ Facteurs de risque	• Non modifiables : âge, sexe masculin, hérédité • Modifiables : surpoids, sédentarité, sel, alcool, tabac
À RETENIR L'HTA est un facteur de risque cardiovasculaire majeur : AVC, insuffisance cardiaque, coronaropathie, néphropathie.	

II | Diagnostic et bilan initial

II	A. Mesure de la pression artérielle
Conditions de mesure	• patient au repos depuis 5 minutes, assis • brassard adapté à la circonférence du bras • mesure aux deux bras lors du bilan initial
★ MAPA	• mesure ambulatoire de la PA sur 24 h • examen de référence pour confirmer le diagnostic • dépiste l'HTA masquée
MOYEN MNÉMOTECHNIQUE Automesure — règle des 3 : 3 mesures matin et soir, 3 jours de suite.	

II	B. Bilan de retentissement
◆ Organes cibles	• Cœur : ECG, hypertrophie ventriculaire gauche • Rein : créatininémie, DFG, protéinurie • Œil : rétinopathie hypertensive si HTA sévère
Bilan biologique	• kaliémie, glycémie à jeun • bilan lipidique, créatininémie
PIÈGE ⚠ Rechercher une HTA secondaire si HTA résistante, sujet jeune ou signes d'orientation.	

Retentissement sur les organes cibles



Figure 2 — Principaux organes cibles atteints par l'hypertension artérielle.

III | Prise en charge thérapeutique

III	A. Mesures non médicamenteuses
Règles hygiéno-diététiques	• réduction des apports en sel (< 6 g/j) • perte de poids en cas de surpoids • activité physique régulière (30 min/j) • limitation de l'alcool, arrêt du tabac

III	B. Traitement médicamenteux		
★ Classes de 1re intention	Classe	Exemple	Indication
	IEC	Ramipril	Diabète, IC
	ARA II	Losartan	Intolérance aux IEC
	I. calcique	Amlodipine	Sujet âgé
	Diurétique	HCTZ	Sujet âgé
◆ Stratégie	• bithérapie d'emblée souvent recommandée • privilégier les associations fixes • objectif : < 140/90 mmHg, voire < 130/80 mmHg		

MOYEN MNÉMOTECHNIQUE

Les 5 classes — moyen mnémotechnique « **A-B-C-D** » : **A**RA II / IEC, **B**êtabloquants, **C**alciques, **D**iurétiques.

Algorithmes décisionnels

Démarche diagnostique devant une PA élevée

- PA $\geq$ 140/90 mmHg au cabinet
- OUI $\rightarrow$ confirmer par **MAPA** ou **automesure**
 - MAPA $\geq$ 135/85 $\rightarrow$ **HTA confirmée** $\rightarrow$ bilan + traitement
 - MAPA $<$ 135/85 $\rightarrow$ **HTA blouse blanche** $\rightarrow$ surveillance
- NON $\rightarrow$ **pas d'HTA** $\rightarrow$ contrôle annuel

Synthèse — Tableaux de révision

Chiffres-clés à connaître

Paramètre	Valeur	Précision
Seuil HTA au cabinet	140/90 mmHg	sur 2 consultations
Seuil en automesure	135/85 mmHg	règle des 3
Apports en sel conseillés	< 6 g/j	mesure hygiéno-diététique
Objectif tensionnel	< 140/90 mmHg	voire < 130/80 si toléré
Prévalence de l'HTA	≈ 30 %	population adulte

Grades de sévérité de l'HTA

Grade	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)
Grade 1	140-159	90-99
Grade 2	160-179	100-109
Grade 3	≥ 180	≥ 110

Classes thérapeutiques de première intention

Classe	Exemple	Indication préférentielle
IEC	Ramipril	Diabète, insuffisance cardiaque
ARA II	Losartan	Intolérance aux IEC (toux)
Inhibiteur calcique	Amlodipine	Sujet âgé
Diurétique thiazidique	HCTZ	Sujet âgé
Bêtabloquant	Bisoprolol	Coronaropathie associée

RÉVISION EXPRESS

Fiche éclair

Hypertension Artérielle

Définition : PA $\geq$ 140/90 mmHg au cabinet (135/85 en automesure), confirmée sur 2 consultations.

Diagnostic : MAPA = examen de référence ; rechercher HTA blouse blanche et HTA masquée.

Bilan : organes cibles (cœur, rein, œil) + bilan biologique minimal ; évoquer une HTA secondaire si résistance ou sujet jeune.

Traitement : RHD systématiques + 5 classes (IEC, ARA II, calciques, diurétiques, bêtabloquants) ; bithérapie d'emblée fréquente ; objectif < 140/90 mmHg.

À retenir absolument

- L'**HTA** est définie par une PA $\geq$ **140/90 mmHg** au cabinet, confirmée sur des mesures répétées.
- La **MAPA** et l'**automesure** confirment le diagnostic et dépistent l'HTA blouse blanche et l'HTA masquée.
- Le bilan initial recherche une **atteinte des organes cibles** et une **HTA secondaire**.
- Les **règles hygiéno-diététiques** sont la base du traitement.
- Cinq classes de 1re intention ; la **bithérapie** est souvent d'emblée.
- Objectif : < **140/90 mmHg**, idéalement < **130/80 mmHg** si toléré.



MAJOR ECN · 2025-2026